Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Santiago

Av. Batista Bonotto, 157 - Bairro: Centro - CEP: 97700000 - Fone: (55)3029-9981 - 55999337784 - Email: frsantiago2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5008270-65.2023.8.21.0064/RS

AUTOR: OTAVIANO SOARES MACHADO

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

OTAVIANO SOARES MACHADO ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, todos já qualificados no processo. Contou, em síntese, ser acometido pelas patologias classificadas pelos CIDs TP53 del 17p, J010 e C 91.1, e que em decorrência de seu diagnóstico, com intuito de evitar danos irreparáveis a sua saúde, necessitava fazer uso do medicamento Imbruvica 140MG. Narrou que o uso do medicamento era indispensável no controle de sua patologia, e que não poderia fazer uso de medicamentos incluídos nas listas do SUS, considerando as especificidades das patologias. Falou que não possui condições financeiras de arcar com seu tratamento sem comprometer sua subsistência. Requereu, em sede liminar, a determinação para que a parte requerida fornecesse o medicamento e, ao final, a total procedência da demanda. Solicitou AJG. Juntou documentos no Evento 01.

A decisão de Evento 09 determinou a remessa do processo ao e-NatJus. A nota técnica foi juntada no Evento 13.

No Evento 16, a inicial foi recebida, concedido o benefício da Justiça Gratuita à parte demandante e deferido o pedido liminar.

Citado, o requerido ofereceu contestação no Evento 28, alegando, em síntese, que o tratamento oncológico buscado pelo autor não encontra previsão no protocolo adotado pela autarquia para tratamento da enfermidade. Ao final, dentre outros pedidos, requereu a total improcedência da ação. Juntou documentos.

Houve réplica (Evento 33).

A decisão de Evento 37, intimou as partes acerca do interesse na produção de provas.

A parte requerida manifestou seu desinteresse na produção de provas, no Evento 44.

No Evento 40, o autor postulou a inclusão do medicamento Venetoclax 100MG.

Com vista, a parte requerida não concordou com a inclusão do medicamento, conforme Evento 59.

A decisão proferida no Evento 62 deferiu o pedido de inclusão.

O Ministério Público opinou pela procedência da ação, conforme parecer de mérito anexado no Evento 124.

Relatei.

Decido.

Primeiramente, passo a analisar a preliminar de pedido genérico.

Analisando a petição inicial, vejo que o pedido da parte autora atende aos requisitos constantes nos arts. 322 e 324 do CPC, vejamos:

> D) no mérito, a procedência do pedido da parte autora, com a consequente confirmação da antecipação de tutela, **determinando ao**
>
> Rua Marechal Deodoro, nº 1020, sala 101
> Centro – Santiago- RS
> Brasil – Cep. 97.700-420
> Telefone: (55) - 3251-9621
> gitalmente em 16/11/2023 17:36 - DPE-RS
> 1c165e6d-e364-4446-9315-d9d5eeedef31 - Código de validação: 9b71c493
>
> DEFENSORIA PÚBLICA
> ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
>
> DEFENSORIA PÚBLICA
> ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
>
> **requerido IPE-SAÚDE, para que forneça à parte requerente o fármaco Imbruvica (Ibrutinibe) 140 MG 90 CP,** a ser administrado **com URGÊNCIA**, ou o **valor correspondente em dinheiro**, sob pena de, em caso de descumprimento, bloqueio do valor correspondente ao fármaco

A postulação abrange o medicamento em questão e, em caso de descumprimento, há o pedido subsidiário de constrição de valores.

Assim, não há o que se falar em pedido genérico.

Consigno que, embora tenha havido a inclusão de outro medicamento, esse fato, por si só, não presume ocorrência de pedido genérico, considerando que, conforme já adiantado na decisão de Evento 62, trata-se de mera adequação ao tratamento do demandante.

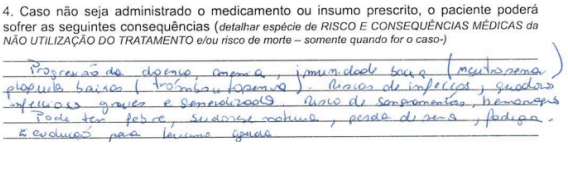
Portanto, **afasto a preliminar**.

No mérito, procede o pedido do autor.

Consigno que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar as poucas condições financeiras da parte autora em despender da quantia necessária para a aquisição dos fármacos que necessita.

Verifico, ainda, que restaram comprovadas a existência da patologia, a necessidade e a urgência na administração do medicamento.

O laudo médico anexado no evento 1, LAUDO14, comprova a gravidade da doença que acomete a autora e a necessidade na administração do fármaco postulado, conforme abaixo:


4. Caso não seja administrado o medicamento ou insumo prescrito, o paciente poderá sofrer as seguintes consequências (*detalhar espécie de RISCO E CONSEQUÊNCIAS MÉDICAS da NÃO UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO e/ou risco de morte – somente quando for o caso-*)

Progressão da doença, anemia, imunidade baixa (neutrofilia), plaquetas baixas (trombocitopenia). Riscos de infecções graves e sangramentos. Risco de sangramentos, hemorragias. Pode ter febre, sudorese noturna, perda de peso, fadiga. Evoluiu para leucemia grave

Ademais, o laudo trazido no evento 40, LAUDO8, indica a necessidade de escalonamento do tratamento com o medicamento Venetoclax, para controle de sua patologia.

Tenho que não pode ser afastada a credibilidade da prescrição efetuada pela profissional que acompanhou o tratamento da demandante, Dra. Litcheia Schreber, CRM 35841, por possuir melhor condição de avaliar o seu estado de saúde e a prescrição recomendada.

Quanto ao fornecimento, ressalto que o pedido não se alicerça na responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, disposta no art. 196 da Constituição Federal, mas na responsabilidade do Plano de Saúde, assim necessário observar as normativas que regulamentam o plano.

Consigno que, em 06 de abril de 2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, revogando, portanto, a Lei Complementar nº 12.134/04.

Desta feita, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu após a entrada em vigor da LC 15.145/2018, esta é a legislação aplicável ao caso.

Tal legislação dispõe sobre o IPE-Saúde e refere que o plano de saúde integra atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, *in verbis*:

> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*

O parágrafo primeiro do artigo acima refere que os tratamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do IPERGS restam excluídos da cobertura do plano de saúde e o parágrafo segundo exige a aprovação do Órgão Gestor para inclusão de novos procedimentos, *in verbis*:

> *§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.*
>
> *§ 2º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.*

Todavia, em que pese as disposições da nova lei, entendo que, neste caso, a ausência de previsão não deve servir de obstáculo ao fornecimento do medicamento postulado (Evento 40).

Consigno que descabe a intervenção do plano de saúde na autonomia do médico, devendo ser respeitada a prescrição trazida pelo profissional que acompanha de forma direta a patologia da autora.

Cabe destacar que a Resolução nº 21/1979, que regulamenta a assistência Médico-Hospitalar do IPERGS, assim dispõe:

> *Artº 2º - O plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes coibirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.*
>
> *§ Primeiro – O Plano será restrito aos princípios da Medicina Curativa sendo, no entanto, admissível em casos especiais a instituição de procedimentos preventivos.*
>
> *§ Segundo – O Plano será fundamental baseado nos seguintes princípios:*
>
> *a) co-participação financeira do usuário.*

b) livre escolha dentre os profissionais ou entidades credenciadas.

Artº 8º - Incluem-se no Plano de Assistência Médica, em consonância com as respectivas normas, as seguintes especialidades:

Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geral, Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia (Alergia), Medicina Nuclear, Nefrologia, Obstetrícia, Oftalmologia, ***Oncologia,*** *Otorrinolaringologia, Patologia Clínica e Cirurgia, Pediatria, Plástica reparadora, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Tisiopneomologia, Torácica, Traumatologia e Urologia. (Grifei)*

(...)

Artº 9º - A assistência médico-hospitalar abrangerá os seguintes serviços:

1 – Emergências

2 – Consultas Médicas

3 – Serviços Complementares

4 – Tratamento Ambulatorial

5 – Tratamento Hospitalar

Desta feita, entendo que o plano de saúde deve fornecer os medicamentos postulados, pois comprovada a enfermidade que acomete o autor, a cobertura do plano para tal enfermidade e a necessidade do uso dos medicamentos.

Importante lembrar que a limitação do critério médico na escolha do procedimento mais adequado ao seu paciente é vedada expressamente pelo art. 16 do Código de Ética Médica (Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.931/09, Anexo, Capítulo I, XVI), conforme se segue:

"Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente."

Também deve ser observado o princípio da boa-fé contratual, pois se o plano oferece cobertura para a enfermidade da autora tal cobertura deve ser a mais ampla possível, sendo irrelevante se o Plano de saúde se institui na modalidade privada ou de autogestão.

Feitos estes esclarecimentos, verifica-se que a inovação legislativa não obstaculiza o direito da parte autora à saúde.

Da mesma forma, estando prevista a patologia que acomete o demandante no rol de cobertura do Plano, não há que considerar os argumentos com relação ao alto custo do procedimento ou eventuais prejuízos financeiros mencionados pelo réu, tratando-se de cumprimento das obrigações contratuais contraídas, pois a autora aderiu ao plano e cabe ao réu oferecer a cobertura contratada.

Ainda, o fato de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, segundo a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não exime o réu de custear o tratamento.

Desta feita é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão, de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

Neste sentido, os precedentes do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO: VENETOCLAX. AUTORA DIAGNOSTICADA COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (CID 10 C92.0). ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória, determinando ao plano de saúde a disponibilização do medicamento Venetoclax à autora, diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda (CID 10 C92.0), sob alegação de urgência e necessidade do tratamento, apesar da negativa administrativa do IPE-Saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade do IPE-Saúde no fornecimento do medicamento solicitado, considerando a legislação aplicável; (ii) a urgência e a necessidade do tratamento prescrito pelo médico da autora; (iii) a possibilidade de negativa de cobertura em razão da ausência do medicamento nas tabelas do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal e pela legislação estadual, sendo dever do plano de saúde assegurar o tratamento necessário ao segurado, independentemente de sua inclusão nas tabelas do IPE-Saúde. 2. A urgência do tratamento é evidenciada pelo diagnóstico da autora e pela recomendação médica, que atesta a necessidade do uso do Venetoclax em associação com azacitidina, visando evitar a progressão da doença. 3. A negativa de cobertura com base na ausência do medicamento nas tabelas do plano é considerada abusiva, uma vez que a escolha do tratamento deve ser pautada pela avaliação médica e não por limitações administrativas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a negativa de cobertura de tratamento essencial, indicado por médico, é vedada, mesmo que o procedimento não conste nas tabelas do plano, nos casos em que não há meios para substituir o pedido. 5. A nota técnica favorável do NATJUS, embora com ressalvas, indica que a autora pode se beneficiar do tratamento, corroborando a urgência da medida e a necessidade de proteção à saúde da demandante. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido, monocraticamente, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela provisória, determinando ao IPE-Saúde a disponibilização do medicamento Venetoclax à autora, no prazo de cinco dias. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995 e 1.019, I; Lei Complementar nº 15.145/2018, art. 4º; Resolução nº 21/1979, arts. 2º, 8º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022, DJe de 3.8.2022. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 50698819520258217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 23-04-2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. SEGURADO PORTADOR DE LINFOMA DE MANTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO: IBRUTINIBE - IMBRUVICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REQUISITOS PRESENTES À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. - O art. 2º da Lei

Complementar n.º 12.134/04, que instituiu o IPE-SAÚDE, dispõe que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, assim como ações de prevenção da doença e promoção à saúde. Não há dúvidas, portanto, acerca da responsabilidade quanto ao fornecimento de qualquer tipo de tratamento, desimportando as razões de negativa do plano de saúde, pois lhe falece legitimidade para selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado. - Presentes os requisitos, deve ser mantido o deferimento do pleito antecipatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70075533828, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 08-03-2018)

Face ao exposto, com bae no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por OTAVIANO SOARES MACHADO para CONDENAR o IPÊ-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL a fornecer ao autor os medicamentos IMBRUVICA (IBRUTINIBE) 140 MG e VENETOCLAX 100 MG na forma e prescrição postuladas.

Confirmo as decisões antecipatórias de tutelas, proferidas nos Eventos 16 e 62.

Deixo de condenar o réu em custas diante da isenção oferecida pela Lei nº 14.634/2014 e contida no Ofício-Circular nº 060/2015-CGJ para ações desta natureza, ajuizadas a partir de 15/06/2015.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do FADEP, os quais fixo em **R$ 800,00**, a serem corrigidos pela TAXA SELIC, o que faço com base no art. 85

Interposta a Apelação pela parte autora/requerida, intime-se a parte adversa para contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada das contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, e nada mais sendo postulado, arquive-se com baixa na distribuição.

Partes intimadas.

Dil. Legais.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA NICHEL SANTOS, Juíza de Direito**, em 05/10/2025, às 21:31:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10090863843v6** e o código CRC **db6032d8**.